

УДК 616.34-006.6-089:616-036.22

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тудеуова, Д.Х. Савхатов, Ж.О.Мауленов, А.А.Исалиев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Выбор варианта пластики при хирургическом лечении местно-распространенного рака кожи

Аннотация. Представлена проблема выбора метода пластики послеоперационного дефекта при местнораспространенном раке кожи. Показано, что Формирование кожно-фасциальных и кожно-мышечных трансплантатов с учетом кровоснабжения позволяет успешно ликвидировать сложные по расположению и рельефу дефекты и добиться удовлетворительных результатов в лечении местнораспространенного рака кожи, а значит, способствует ранней реабилитации больных, возвращению их к обычному образу жизни и труду.

Ключевые слова: пластика, рак кожи.

Актуальность

По данным ВОЗ в 21 веке прогнозируется рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи, в частности местнораспространенных форм, что приводит к вопросу ранней диагностики, и подбора оптимальных методов лечения. Неуклонный рост злокачественными новообразованиями кожи во всем мире называют «тихой эпидемией». Несмотря на кажущуюся простоту визуальной диагностики опухолей наружной локализации, до сих пор уровень выявления рака нельзя признать удовлетворительным [1,2,4].

В республике Казахстан также отмечается тенденция к значительному росту новообразований кожи, усилению тяжести заболевания, выявлению больных запущенными

формами злокачественного процесса, с низкой гистологической дифференцировкой, с инвазией в подлежащие ткани. В структуре онкологической заболеваемости рак кожи среди мужского населения занимает 2 место (10,6%), уступая раку легкого, среди женщин – 1 место [8]. Причем возрастает удельный вес пациентов с Т3-Т4 (50%), что свидетельствует о несвоевременном обращении за медицинской помощью, либо о том, что на ранних стадиях больные получают лечение по месту обращения. Лечение рака кожи, в частности, лица представляет определенные трудности из-за сложности анатомического строения этой области, многообразия функций и близости органов, имеющих функциональное и эстетическое значение, и является актуальной задачей [6].

Хотя течение рака кожи относительно благоприятное, в запущенных стадиях не всегда удается радикально излечить заболевшего. Иногда приходится прибегать к очень большим, калечащим операциям в виде широкого иссечения тканей лица, в результате которых образуются обширные раневые дефекты [3,5,7].

Цель исследования

Выбор оптимального метода пластики послеоперационного дефекта при местнораспространенном раке кожи.

Материалы и методы исследования

В отделении костей и мягких тканей КазНИИОнР за 2009 - 2010гг. пролечено 14 больных. Возраст составлял от 30 до 75 лет. У всех больных диагноз верифицирован.

У всех 14 (100%) больных установлена Т3 стадия заболевания. Плоскоклеточный рак встретился в 5 (35,7%) случаях, базальноклеточный – в 7 (50%), метатипический – в 3 (21,4%) случае. Во всех наблюдениях выполнение операций сопровождалось блоковым удалением опухоли и окружающих тканей, отступя 0,5-1 см. от краев и глубиной до мышечного апоневроза.

В зависимости от локализации опухоли применяли различные виды пластической хирургии:

1. при локализации опухоли теменно-затылочной области послеоперационный дефект закрывался кожно-фасциальным лоскутом с области верхнего надплечья.
2. при локализации в височной области и носогубной складки применялся кожно-фасциальный лоскут из щеки.

Интраоперационно всем больным



производилась цитологический контроль краев резекции. Ни в одном случае опухолевые клетки по краям послеоперационной раны не обнаружены.

Результаты лечения

В послеоперационном периоде осложнение в виде краевого некроза наблюдалось у 2 больных. У остальных больных заживление раны первичным натяжением.

Через 6 - 12 месяцев на контрольном осмотре наблюдаемых больных - рецидивов и МТС не отмечено.

Вывод

Формирование кожно-фасциальных и кожно-мышечных трансплантатов с учетом кровоснабжения позволяет успешно ликвидировать сложные по расположению и рельефу дефекты и добиться удовлетворительных результатов в лечении местнораспространенного рака кожи, а значит, способствует ранней реабилитации больных, возвращению их к обычному образу жизни и труду.



Список литературы

1. Максимова Н.Е., Шабанов А.М. Прогнозирование частоты базалиом //Актуальные проблемы пато- и морфогенеза. Системные аспекты патологии и вопросы преподавания патологической анатомии: Сб. трудов науч. конф., посвященной 100-летию каф. патол. анатомии. С. -Петербург. гос. мед. ун-та им. И.П. Павлова - СПб, 1999. - С.46 - 47.
2. Журавель В.Г. К вопросу о лечении больных базальноклеточным и плоскоклеточным раком кожи //Росс. журн. кожн. и венер. болезней.-1999. - №3. С.4 - 7.
3. Неробеев А.И., Акопян И.Г., Уткин Д.В. // Рос онкол. журнал - 2002. - №2. - С. 31 - 33.
4. Шенталь В., Пустынский И.Н., Малаев С.Г. Рак кожи // Мед. помощь. - 2000.- №4. - С. 6 - 10.
5. Robinson J.K. // Dermatol. Surg. - 2004. - Vol.30. - P. 67 - 74.
6. Atlas of cancer of the skin. Edited by Gunter Burg, MD. Churchill Livingstone, 2000.
7. Васильева С.В. Практическая хирургия в онкологии. - Челябинск, 2002.
8. Нургазиев К. Ш., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2010г. (статистические материалы).- Алматы, 2010. - 52 с.

Тұжырым

Терінің жергілікті жайылмалы қатерлі ісіктерінің хирургия емдеу тәсілдерін ыңғайластырамыз.

Бүкіл әлемде тері қатерлі ісігің өсуі «тыныш эпидемия» деп аталады. Қазақстан Республикасында да терінің қатерлі ісігің біршама өсу тенденциясы байқалады. Тері қатерлі ісігің T3 - T4 сатысында жа-

салатын амалдар көбіне беттің жұмсақ тіндерінің үлкен ақауларға алып келеді. Ол науқастардың қалыпты өмір сүруін бір шама төмендетеді. Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының сүйек және жұмсақ тіндер қатерлі ісіктер бөлімінде пластикалық хирургияның әр түрлі амалдары орындалады.

Summary

G. Serikbaev, D. Tuleuova, D. Savkhatov, Gh. Maulenov, A. Isaliev.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology Surgeon treatment S improvement of local dissemination forms of the skin cancer.

In the whole world the steadfast growth of tumors is called "the quiet epidemic". The skin cancer also grows in the Kazakhstan and in the cancer structure it takes 2-nd seat. The operations which are make to patients with skin cancer with T3 - T4 stage give vast defects on the face, that significantly make worse the life quality. In the tumors of bones and soft tissue department of Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology we make operations with different sights of plastic surgery.

Keywords: sarcoma of soft tissue surgery.